

Trzy wymiary *wypalenia zawodowego*

Wyczerpanie + cynizm + obniżone poczucie dokonań. ICD-11 (QD85): zjawisko zawodowe, nie zaburzenie psychiczne.

CZAS: 15 min psychoedukacji **REALIZACJA:** pierwsza sesja

ŹRÓDŁO: Maslach & Jackson (1981, MBI); Maslach, Schaufeli & Leiter (2001, *Annu Rev Psychol*); Maslach & Leiter (2016, *World Psychiatry*); ICD-11 (2019, QD85)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **trzy wymiary wypalenia** według MBI Maslach: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja/cynizm, obniżone poczucie dokonań osobistych. Każdy wymiar oddzielnie, bo profil wymiarów decyduje o interwencji. W sekcji 02 — **status diagnostyczny**: ICD-11 (QD85) klasyfikuje wypalenie jako „zjawisko zawodowe”, nie zaburzenie. Sekcja 03 — **różnicowanie z depresją**: wypalenie jest kontekstowe (związane z pracą), depresja jest ogólna. Sekcja 04 — twoje samoocena trzech wymiarów (0–10) i wstępna hipoteza.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Maslach i Jackson (1981) opracowały *Maslach Burnout Inventory* (MBI) — najczęściej cytowany instrument do pomiaru wypalenia. Wypalenie według MBI ma **trzy niezależne wymiary**: (1) **wyczerpanie emocjonalne** (brak energii, zmęczenie nieustępujące po odpoczynku, „pusty zbiornik”); (2) **depersonalizacja / cynizm** (dystans wobec pracy i ludzi, sarkazm, obojętność, postrzeganie klientów/pacjentów/uczniów jako „przypadków” zamiast osób); (3) **obniżone poczucie dokonań osobistych** (poczucie nieskuteczności, „po co to robię?”, spadek samooceny zawodowej). Wymiary są *niezależne*: pacjent może mieć wysokie wyczerpanie bez cynizmu, lub wysoki cynizm bez spadku poczucia skuteczności. **Profil decyduje o interwencji**. Maslach, Schaufeli i Leiter (2001, *Annual Review of Psychology*): wyczerpanie zwykle pojawia się pierwsze; cynizm rozwija się jako mechanizm obronny przed dalszym wyczerpaniem; spadek skuteczności pojawia się na końcu (Maslach i Leiter, 2016). ICD-11 (2019) klasyfikuje wypalenie jako kod **QD85** — „zjawisko zawodowe” (ang. *occupational phenomenon*), nie zaburzenie psychiczne; to *kontekstowa* diagnoza związana wyłącznie z pracą. Konsekwencja kliniczna: *nie używaj „wypalenia” jako etykiety zamienniej z depresją*. Wypalenie + obniżenie nastroju we wszystkich domenach (a nie tylko zawodowej) = wskazanie do screeningu depresji (PHQ-9). Maslach i Leiter (2016): wypalenie i depresja często współistnieją, ale nie są tym samym — depresja wymaga innego leczenia, w tym farmakologicznego.

01 Trzy niezależne wymiary wypalenia

1 · WYCZERPANIE EMOCJONALNE

Brak energii. Zmęczenie nieustępujące po weekendzie. Poranne wstawanie z wysiłkiem. Wieczorne wyczerpanie po normalnym dniu. Niemożność „naładowania baterii”. *Pojawia się zwykle pierwsze.*

2 · DEPERSONALIZACJA / CYNIZM

Dystans wobec ludzi i pracy. Sarkazm, obojętność, postrzeganie klientów / pacjentów / uczniów jako „przypadków”. *Mechanizm obronny przed dalszym wyczerpaniem — rozwija się jako druga faza.*

3 · OBNIŻONE DOKONANIA

„Po co to robię?” Poczucie nieskuteczności, spadek samooceny zawodowej, dewaluacja własnej pracy. „Nic z tego, co robię, nie ma znaczenia”. *Pojawia się na końcu — wzmacnia cykl wycofania.*

02 ? Status diagnostyczny — ICD-11 QD85

ICD-11 (2019, WHO) klasyfikuje wypalenie pod kodem **QD85** jako „**zjawisko zawodowe**” (ang. *occupational phenomenon*) — *nie* jako zaburzenie psychiczne. To kontekstowa diagnoza związana **wyłącznie** z pracą. Definicja ICD-11: „*zespół wynikający z chronicznego stresu w miejscu pracy, który nie został skutecznie opanowany*”. Trzy elementy: poczucie wyczerpania energii, mentalny dystans od pracy, obniżona skuteczność zawodowa.

Konsekwencja: wypalenie nie podlega refundacji jako zaburzenie psychiczne; klinicznie funkcjonuje jako diagnoza pomocnicza, kontekst dla depresji adaptacyjnej, zaburzenia stresowego lub współistniejących zaburzeń lękowych/depresyjnych.

03 ? Różnicowanie: wypalenie kontra depresja

WYPALENIE — KONTEKSTOWE

Związane wyłącznie z pracą. Pacjent zwykle zachowuje energię i radość w innych domenach: weekend z rodziną cieszy, hobby angażuje, wakacje regenerują (przynajmniej krótko). Anhedonia *specyficzna* dla pracy. ICD-11 QD85.

DEPRESJA — UOGÓLNIONA

Obejmuje wszystkie domeny życia. Anhedonia uogólniona (nic nie cieszy), poczucie beznadziei, myśli śmiertelne, zaburzenia snu/apetytu poza kontekstem pracy, wakacje nie pomagają. ICD-11: zaburzenie depresyjne (6A70-6A73).

Zasada kliniczna: jeśli pacjent zgłaszający wypalenie *nie* odczuwa radości i energii także poza pracą — przeprowadź screening depresji (PHQ-9). Maslach i Leiter (2016): współwystępowanie sięga 30-50%, ale wymagają różnych interwencji. Depresja może wymagać farmakoterapii — wypalenie wymaga zmiany warunków pracy.

04 ? Samoocena trzech wymiarów (0–10)

To *nie* jest pomiar MBI (do tego potrzebny jest pełny test pod nadzorem klinicznym). To wstępna mapa do rozmowy z terapeutą lub własnej refleksji.

WYMIAR	MÓJ WYNIK 0–10	CO KONKRETNIE? — PRZYKŁAD SYTUACJI Z OSTATNIEGO TYGODNIA
1 · Wyczerpanie jak bardzo jestem wyczerpany/-a emocjonalnie		
2 · Cynizm jak bardzo zdystansowałem/-am się od pracy / ludzi		
3 · Spadek dokonań jak nisko oceniam wartość swojej pracy		

MOJA WSTĘPNA HIPOTEZA — KTÓRY WYMIAR JEST NAJSILNIEJSZY

— i czy odczuwam wyczerpanie i anhedonię także poza pracą (jeśli tak — rozmowa z lekarzem o screeningu depresji)

Klucz: wypalenie to *nie* słabość ani lenistwo — to **odpowiedź organizmu** na chroniczny brak równowagi między wymaganiami pracy a zasobami (model JD-R: *Job Demands-Resources*). Profil trzech wymiarów decyduje o interwencji: wysokie *wyczerpanie* wskazuje na pracę nad regeneracją i ograniczeniem obciążenia; wysoki *cynizm* — na pracę nad sensem, wartościami i relacjami w zespole; *spadek dokonań* — na pracę nad rekonstrukcją poczucia skuteczności (mikro-sukcesy, modyfikacja zakresu pracy, weryfikacja kryteriów oceny). Same warsztaty *mindfulness* dla wszystkich = niska skuteczność, bo nie biorą pod uwagę profilu wymiarów ani warunków organizacyjnych.